Cirurgia realizada:

Nome do cirurgião: 221 - Caio

Auxiliar:

Instrumentadora: Mariana

Hora de saída da S.O: Circulante assinatura: Sandra

Paciente encaminhado para:

☐ SRPA ☐ CTI ☐ PA ☐ Alta ☐ Necrotério ☐ Rosa ☐ Azul ☑ Verde Assinatura:

4 - SRPA

Admissão do paciente:

Nivel de consciência: ☐ Lúcido ☐ Comatoso ☐ Consciente ☐ Torporoso

☐ Desorientado ☐ Agitado ☐ Outros:

Queixas:

☐ Dor ☐ Emese ☐ Náuseas ☐ Frio ☐ Dispneia ☐ Tontura ☐ Sem queixas

☐ Outros:

	15'	30'	45'	60'	1h30	2h
Sinais Vitais						
PA						
Pulso / FC						
Temperatura						
SPO2						
Escala dor						
Descritiva verbal						
Visual analógica						

ESCALA DE ALDRETE E KROULIK

Parâmetro	Resposta	Pontos	15'	30'	45'	60'	1h30'
	Movimenta os quatros membros	2					
Atividade muscular	Movimenta dois membros	1					
	Incapaz mover membros voluntariamente ou sob comando	0					
	Capaz de respirar profundamente	2					
Respiração	Dispneia ou limitação da respiração	1					
	Apneia	0					
	PA com variação de ate 20% do nível pré-anestésico	2					
Circulação	PA com variação de 20 a 49% do nivel pré-anestésico	1					
	PA com variação acima de 50% do nivel pré-anestésico	0					
	Lúcido e orientado no tempo e espaço	2					
Consciência	Desperta, se solicitado	1					
	Não responde	0					
	Capaz de manter SPO2> 92%, respirando em ar ambiente	2					
Saturação de O2	Necessita de O2 para manter SPO2> 90%	1					
	SPO2<90% com suplementação de O2	0					
Total pontos	Obs.: 8 a 10 pontos, paciente apto para alta	-					

	DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM
	01 Ansiedade
	02 Dor aguda
	03 Integridade da pele prejudicada
	04 Hipotermia
	05 Mobilidade física prejudicada
	06 Náuseas
	07 Padrão respiratório ineficaz
	08 Risco de confusão aguda
	09 Confusão aguda
	10 Perfusão tissular ineficaz
	11 Retenção urinária
	12 Risco para aspiração
	13 Risco para infecção
	14 Temperatura corporal desequilibrada
	15 Volume de líquido deficiente
	16 Volume de líquido excessivo
	17
	18

	INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
	01 - Permanecer com o paciente e identificar suas necessidades
	02 - Proporcionar tranquilidade e conforto
	03 - Avaliar o nível e os sinas de dor
	04 - Administrar analgésicos prescritos ou consultar o Anestesista
	05 - Utilizar métodos alternativos, como mudança de posição
	06 - Avaliar ferida e curativo cirúrgico
	07 - Aquecer o paciente com cobertores e infundir soro aquecido
	08 - Posicionar o paciente confortavelmente
	09 - Administrar antieméticos conforme prescrição médica
	10 - Lateralizar a cabeça do paciente
	11 - Avaliar o estado respiratório na admissão da SRPA
	12 - Incentivar a respiração profunda
	13 - Administrar oxigênio umidificado
	14 - Avaliar o nível de consciência e orientar o paciente no tempo e espaço
	15 - Manter em decúbito elevado a 45°
	16 - Aspirar secreções se necessário
	17 - Utilizar técnicas assépticas durante os procedimentos
	18 - Monitorizar sinais vitais e ECG
	19 - Monitorar perdas por drenos
	20 - Monitorar balanço hídrico
	21 - Posicionar em trendelenburg
	22 - Passar sonda vesical de alívio, conforme solicitação médica
	23 -

	Retenção urinária
	Hipotensão arterial
	Hipertensão arterial
	Bradicardia
	Taquicardia
	Arritmia
	Hemorragia
	Obstrução de vias aéreas Broncoespasmo
	Apneia
	Dispneia
	Hipoventilação

	Hipoxia
	Prurido
	Náuseas/ Vômitos
	Regurgitação
	Broncoaspiração
	Hipotermia
	Hipertemia
	Oliguria/ Anuria Agitação
	Reação Alérgica
	Convulsão

MEDICAMENTOS	HORÁRIO
Dipirona 2amp.	21:30
Cefazolina 2gms	20:20
Metergin	
Transamin	
Tramal	
Diazepan	
Dormonid	
Profenid	
Oxitocina	
Nubain	
Nausedran 1amp.	21:30
Plasil	
Metronidazol	
Garamicina 240mg	20:20
Fernegan	
Decadron	

ETIQUETAS:

ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM NA RA
Assinatura do profissional de enfermagem da RA: COREN:

Paciente encaminhado para:

☐ CTI ☐ PA ☐ Alta ☐ Necrotério ☐ Rosa ☐ Azul ☒ Verde

Realizado passagem de plantão: ☐ Sim ☐ Não

Peça cirurgia identificada adequadamente

Recebida por:_____

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA:

CAMPO BELO

NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE — Santa Casa

Nome: Nicolas Teixeira Domiciano

Data: 26 / 09 / 2022 Idade: 20a Hora: 07:15

Sexo: [X] M [ ] F Convênio: Unimed

Cirurgia Proposta: Fratura da patela esquerda

1- CHEGADA DO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

Setor de Origem: _____

Procedimento Proposto Acesso Venosos Periférico [ ] Sim [ ] Não

Tricotomia [ ] Sim [ ] Não / Jejum [ ] Sim [ ] Não

CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO:

Termo de consentimento assinado [ ] Sim [ ] Não

Dados de Identificação na pulseira checados [ ] Sim [ ] Não

Risco cirúrgico [ ] Sim [ ] Não

Exames pré-operatórios [ ] Sim [ ] Não

Retirada de pertences e adornos e entregue para: _____

Responsável pelo preenchimento: _____

Banho [ ] Sim [ ] Não

Antibiótico profilático [ ] Sim [ ] Não

Qual: _____

2- PRÉ-OPERATÓRIO IMEDIATO – ADMISSÃO C.C.

Como chegou?

[ ] Deambulando [X] Maca [ ] Cadeira [ ] Colo [X] Consciente

[ ] Inconsciente [X] Orientado [ ] Desorientado [ ] Sedado

Comorbidades: [ ] DIA [ ] HAS [ ] Outros, especificar: _____

Exames pré-operatórios: [X] Sim [ ] Não

Alergias: [ ] Não [ ] Sim, especificar: _____

Medicações em uso: _____

Esta em jejum? [X] Sim [ ] Não

Prótese dentaria e adornos retirados: [X] Sim [ ] Não

Portanto cateteres: [X] Não [ ] Sim, especificar: _____

Acesso venoso pérvio: [X] Sim [ ] Não [ ] Realizado no ato cirúrgico

Lateralidade confirmada: [X] Sim [ ] Não

Demarcação feita: [X] Sim [ ] Não

Reserva de hemoderivados: [ ] Sim [X] Não

Reserva CTI: [ ] Sim [X] Não

Esvaziamento vesical: [ ] Sim [X] Não

Tricotomia: [X] Sim [ ] Não [ ] Feita em ato

Banho [ ] Sim [ ] Não

Antibiótico profilático [ ] Sim [ ] Não

Qual: _____

	DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM		INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
—	1. Ansiedade		1. Incentivar a verbalização de sentimentos
	2. Conhecimento deficiente		2. Estimular perguntas sobre o procedimento
—	3. Medo		3. Permanecer com o paciente e identificar suas necessidades
	4. Padrão de sono prejudicado		4. Proporcionar tranquilidade e conforto
	5. Risco de integridade da pele prejudicada		5. Explicar as atividades de rotina do Centro Cirúrgico
	6. Risco de quedas		6. Utilizar técnica asséptica durante os procedimentos
	7.		7. Auxiliar na deambulação
	8.		8.
	9.		9.

3- ADMISSÃO NA S.O

2.1 Antes da indução anestésica

Conferência da limpeza: [X] Sim [ ] Não

Qual sala? [X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4

Dados vitais: PA: 107/45 TAX: - FC: 78

Procedimento cirúrgico confirmado: [X] Sim [ ] Não

Lateralidade marcada e confirmada: [X] Sim [ ] Não

Risco de perca sanguínea: [X] Sim [ ] Não

EQUIPAMENTOS FUNCIONANTES:

EQUIPAMENTO	SIM	NÃO
Foco		
Cautério		
Aspirador		
Mesa Cirúrgica		
Monitor Multiparametrico		

Tipo de anestesia: [X] Raqui [ ] Pendural [ ] Geral [ ] Sedação [ ] Local [ ] Outros: _____

Nome do anestesista: Dr. Marco Antonio

Horário do inicio da anestesia: 08:25

2.2 Antes da incisão cirúrgica

Equipe toda confirma verbal o procedimento e nome do paciente: [X] Sim [ ] Não

Antissepsia feita com [ ] Clorexidina [X] PVPI [ ] Outros: _____

CIRURGICO – SO

—	DORSAL
	VENTRAL
	SEMI FOWLER
	LITOTÔMICA (GINECOLÓGICA)
	LATERAL DIREITO
	LATERAL ESQUERDO
	TRENDELENBURG
	FOWLER
	PROCLIVE
	CANIVETE

Local da placa: _____

2.3 Durante o ato

Incisão iniciada: 08:45

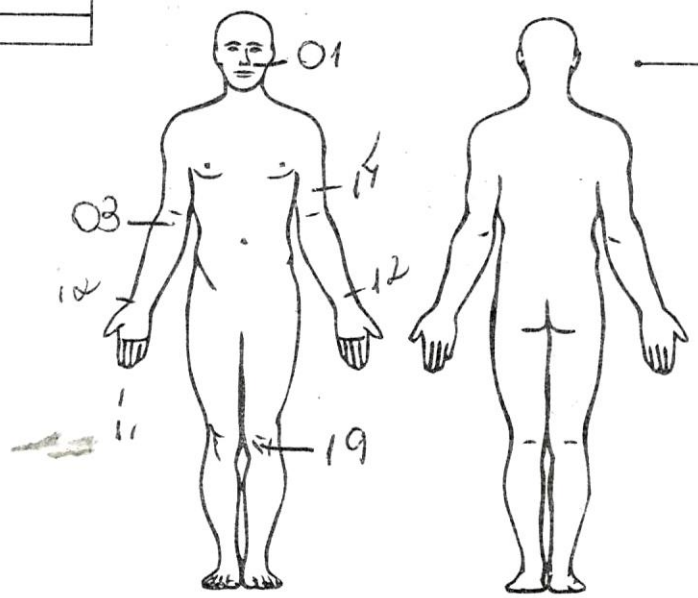
Grau de contaminação: ☐ Limpa ☐ Contaminada ☐ Potencial contaminada ☐ Infectada

Dados vitais: PA: _____ TAX: _____ FC: _____ SAT: _____

Feito uso do aparelho raio x : ☒ Sim ☐ Não

Feito hemotransfusão: ☒ Não ☐ Sim, qual? _____

Feito uso de antibiótico: ☐ Não ☒ Sim Cefazolina horário: 07:30



LOCALIZAÇÃO NO PACIENTE

01 - Cateter O2
02 - Eletrodos
03 - Cateter venoso periférico
04 - Intubação
05 - Cateter venoso central
06 - Placa neutra
07 - Sonda gástrica
08 - Traqueostomia
09 - Sonda vesical de demora
10 - Dreno tórax D/E
11 - Oximetro
12 - Faixas de restrição
13 - Pressão arterial media (PAM)
14 - Pressão não invasiva (PNI)
15 - Garrote pneumático
16 - Dreno
17 - Termômetro
18 - Coxins
19 - Incisão
20-

Anatomo patológico coletado: ☐ **Não** ☐ **Sim**

Preparado por: _____ **Checado por:** _____

Contagem de material

	Quantidade oferecida	Quantidade recolhida
Compressas	2	2
Gazes	1	1
Instrumental	etiqueta	etiqueta
Agulhas		
Lâminas de bisturi	1	1

Curativo cirúrgico/ local/ condições: OK

Extremidades: ☒ Aquecidas ☐ Frias ☐ Cianótica ☐ Perfundida

Drenos: ☒ Não ☐ Sim, especificar: _____

Diurese: ☒ Espontânea ☐ Ausente ☐ SVD ☐ SVA

	DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM
	1. Ansiedade
	2. Risco de aspiração
	3. Risco de desequilíbrio na temperatura corporal
	4. Risco de infecção
	5. Risco de lesão (por bisturi elétrico)
	6. Risco de lesão (por posicionamento perioperatório)
	7. Risco de volume de liquido deficiente
	8. Risco de desequilíbrio do volume de líquidos
	9. Risco de sangramento
	10. Risco de sangramento
	11. Hipotermia
	12.
	13.

	INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
	1 Permanecer com o paciente e identificar suas necessidades
	2 Proporcionar tranquilidade e conforto
	3 Aspirar secreções
	4 Observar o posicionamento do paciente e a presença de secreções
	5 Auxiliar o Anestesista durante a intubação e no período de reversão anestésica
	6 Observar cianose labial e dos leitos ungueais
	7 Elevar a temperatura do ambiente
	8 Utilizar cobertores
	9 Infundir líquidos aquecidos
	10 Sempre que possível manter as regiões do corpo do paciente cobertas
	11 Utilizar técnicas asséptica durante o procedimento
	12 Manter o menor numero de pessoas dentro da sala cirúrgica
	13 Evitar derramamento de liquido na unidade de Eletrocirurgia (UEC)
	14 Inspecionar a (UEC), antes do uso, quanto a fios desencapados, dobrados e nós
	15 Após o posicionamento do paciente, certificar-se de que ele não esta encostado em nenhum metal ou equipamento
	16 Utilizar dispositivo de posicionamento
	17 Realizar a transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica sem puxar ou empurrar
	18 Usar coxins
	19 Manter hidratação venosa pérvia
	20 Infundir hemocomponentes
	21 Observar balanço hídrico
	22 Observar sinais vitais (FC, PA E SPO2)
	23 Fechar drenos durante transporte
	24 Auxiliar na paramentação
	25 Fiscalizar técnicas assépticas

Horário de fim do ato cirúrgico: _____ Cirurgia realizada: primeira parte cesárea

Nome do cirurgião: Dr. Caio

Auxiliar: Dr. Ricardo

Instrumentadora: _____

Hora de saída da S.O: _____ Circulante assinatura: Larione, Fernando, Dani

Paciente encaminhado para:

[X] SRPA [ ] CTI [ ] PA [ ] Alta [ ] Necrotério [ ] Rosa [X] Azul [ ] Verde Assinatura: _____

Fernando José Custódio
Téc. de Enfermagem
COREN MG 1704325 - TEC

4 - SRPA

Admissão do paciente: _____

Nivel de consciência: [ ] Lúcido [ ] Comatoso [ ] Consciente [ ] Torporoso

[ ] Desorientado [ ] Agitado [ ] Outros: _____

Queixas:

[ ] Dor [ ] Emese [ ] Náuseas [ ] Frio [ ] Dispneia [ ] Tontura [ ] Sem queixas

[ ] Outros: _____

	15'	30'	45'	60'	1h30	2h
Sinais Vitais	—					
PA	109x53	110x80				
Pulso / FC	73	70				
Temperatura	—	—				
SPO2	100	98				
Escala dor	0	0				
Descritiva verbal	OK	OK				
Visual analógica						

ESCALA DE ALDRETE E KROULIK

Parâmetro	Resposta	Pontos	15'	30'	45'	60'	1h30'
	Movimenta os quatros membros	2					
Atividade muscular	Movimenta dois membros	1	1				
	Incapaz mover membros voluntariamente ou sob comando	0					
	Capaz de respirar profundamente	2	2				
Respiração	Dispneia ou limitação da respiração	1					
	Apneia	0					
	PA com variação de ate 20% do nível pré-anestésico	2	2				
Circulação	PA com variação de 20 a 49% do nivel pré-anestésico	1					
	PA com variação acima de 50% do nivel pré-anestésico	0					
	Lúcido e orientado no tempo e espaço	2					
Consciência	Desperta, se solicitado	1	1				
	Não responde	0					
	Capaz de manter SPO2> 92%, respirando em ar ambiente	2	2				
Saturação de O2	Necessita de O2 para manter SPO2> 90%	1					
	SPO2<90% com suplementação de O2	0					
Total pontos	Obs.: 8 a 10 pontos, paciente apto para alta	-	8				

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM

	01 Ansiedade
	02 Dor aguda
	03 Integridade da pele prejudicada
	04 Hipotermia
	05 Mobilidade física prejudicada
	06 Náuseas
	07 Padrão respiratório ineficaz
	08 Risco de confusão aguda
	09 Confusão aguda
	10 Perfusão tissular ineficaz
	11 Retenção urinária
	12 Risco para aspiração
	13 Risco para infecção
	14 Temperatura corporal desequilibrada
	15 Volume de líquido deficiente
	16 Volume de líquido excessivo
	17
	18

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

	01 - Permanecer com o paciente e identificar suas necessidades
	02 - Proporcionar tranquilidade e conforto
	03 - Avaliar o nível e os sinas de dor
	04 - Administrar analgésicos prescritos ou consultar o Anestesista
	05 - Utilizar métodos alternativos, como mudança de posição
	06 - Avaliar ferida e curativo cirúrgico
	07 - Aquecer o paciente com cobertores e infundir soro aquecido
	08 - Posicionar o paciente confortavelmente
	09 - Administrar antieméticos conforme prescrição médica
	10 - Lateralizar a cabeça do paciente
	11 - Avaliar o estado respiratório na admissão da SRPA
	12 - Incentivar a respiração profunda
	13 - Administrar oxigênio umidificado
	14 - Avaliar o nível de consciência e orientar o paciente no tempo e espaço
	15 - Manter em decúbito elevado a 45°
	16 - Aspirar secreções se necessário
	17 - Utilizar técnicas assépticas durante os procedimentos
	18 - Monitorizar sinais vitais e ECG
	19 - Monitorar perdas por drenos
	20 - Monitorar balanço hídrico
	21 - Posicionar em trendelenburg
	22 - Passar sonda vesical de alívio, conforme solicitação médica
	23 -

	Retenção urinária
	Hipotensão arterial
	Hipertensão arterial
	Bradicardia
	Taquicardia
	Arritmia
	Hemorragia
	Obstrução de vias aéreas Broncoespasmo
	Apneia
	Dispneia
	Hipoventilação

	Hipoxia
	Prurido
	Náuseas/ Vômitos
	Regurgitação
	Broncoaspiração
	Hipotermia
	Hipertemia
	Oliguria/ Anuria Agitação
	Reação Alérgica
	Convulsão

MEDICAMENTOS	HORÁRIO
Dipirona	
Cefazolina 2 g	07:30
Metergin	
Transamin	
Tramal	
Diazepan	
Dormonid	
Profenid	
Oxitocina	
Nubain	
Nausedran	
Plasil	
Metronidazol	
Garamicina	
Fernegan	
Decadron	

ETIQUETAS:

Rosa/Rose → Marron/Brown AUTOCLAVE/VAPOR

CME

Data da esterilização: 21 0922

Validade: 21/12/22

Autoclave nº: 1 Lote: 28 Ciclo: 5

Descrição/ caixa: pequena cirurgia vermelho listrado

Total de peças: 17

Lavado por: Eliana

Preparado Por: Gabi

ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM NA RÀ

07:15. Procedimento cirurgico realizado em intercorrencia. Apos o ato cirurgico o paciente sera encaminhado para (SRPA) aos cuidados da enfermagem demais informaçoes passadas verbalmente.

Fernando José Custódio
Téc. de Enfermagem
COREN MG 1704325 - TEC

09:52 HS: Paciente admitido no (SRPA) logo após procedimento FRAT da patela ⓓ, pouco sonolento, em AA, lúcido, responsivo aos estímulos, mantendo STP, sem queixas.

11:00 HS: Paciente liberado do SRPA, lucido, em AA, com STP, acompanhado pela equipe de enfermagem pl Ala Apto 01, sem intercorrências, segue cuidados de Enfermagem

Cleidiane F. da Silva
COREN-MG 001.055.91

Assinatura do profissional de enfermagem da RA: COREN:

Paciente encaminhado para:

☐ CTI ☐ PA ☐ Alta ☐ Necrotério ☐ Rosa ☐ Azul ☐ Verde

Realizado passagem de plantão: ☐ Sim ☐ Não

Peça cirurgia identificada adequadamente

Recebida por: _____

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA:

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO
EVOLUÇÃO MÉDICA

Nº DO ATEND.: 676354 NOME: **NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO**
LEITO: IDADE: **20a 6m** SEXO: **M** ORIGEM: **AGUANIL**
CATEGORIA: **UNIMED**

Data/Hora: 22/09/22 21:02

EVOLUÇÃO MEDICA: #ORTOPEDIA

#ACIDENTE AUTOMOBILISTICO 23/09/2022
#FRATURA EXPOSTA DE PATELA ESQUERDA + LESAO DO RETINACULO DO JOELHO DIREITO

BC: DESBRIDAMENTO + SUTURAS DAS LESOES. ATO SEM INTERCORRENCIAS

CD:A SRPA
MANTER ATB 72H
FAMILIA AVENTANDO A POSSIBILIDADE DE TRANSFERENCIA CASO CONTRARIO PROGRAMAR PARA PROXIMA SEGUNDA DIA 26/09/2022

|LADO
CAIO CESAR MAIA
CRM:69866-MG

Dr. Caio Maia
Ortopedista e Traumatologista
CIRURGIA DO JOELHO
CRM 69.866

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO
EVOLUÇÃO MÉDICA

Nº DO ATEND.: **676366** NOME: **NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO**
LEITO: **CLFC01** IDADE:**20a 6m** SEXO: **M** ORIGEM: **AGUANIL**
CATEGORIA: **UNIMED**

Data/Hora: 24/09/22 16:52

EVOLUÇÃO MEDICA:ORTOPEDIA - EVOLUÇÃO

PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO.

TRAUMA EM AMBOS OS JOELHOS.

RX.: FRATURA PATELA ESQUERDA - TRAÇO TRANSVERSO E LESÃO DO RETINACULO EXTENSOR JOELHO DIREITO.

PROPOSTA DE TRATAMENTO CIRURGICO SEGUNDA-FEIRA (26/09/22).

EM USO DE TALA GESSADA INGUINO-MALEOLAR BILATERAL.

HD.: FRATURA PATELA ESQUERDA
LESÃO RETINACULO EXTENSOR JOELHO DIREITO

CD.: ACOMPANHO + PRESCREVO
PROPOSTA DE CIRURGIA COM DR CAIO SEGUNDA-FEIRA (26/09/22)
SOLICITO EXAMES PRE-OPERATÓRIOS

|LADO
IVAN FERREIRA REZENDE
CRM:61894-MG

Dr. Ivan Ferreira Rezende
RQE Nº 420 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
TEOT 163 CRM-MG 61894
CO 5050277

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO

EVOLUÇÃO MÉDICA

Nº DO ATEND.: **676354** NOME: **NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO**
LEITO: IDADE:**20a 6m** SEXO: **M** ORIGEM: **AGUANIL**
CATEGORIA: **UNIMED**

Data/Hora: 24/09/22 03:12

EVOLUÇÃO MEDICA:REAVALIAÇÃO

PACIENTE RETORNA PARA SALA DE EMERGÊNCIA APÓS SUTURA EM BLOCO CIRÚRGICO, REALIZADA POR ESPECIALISTA, DEVIDO A HEMATÊMESE DE PEQUENA MONTA + EDEMA CERVICAL BILATERAL A ESCLARECER. AVALIO PACIENTE TRANQUILO NO LEITO, RELATANDO MELHORA DA DOR EM JOELHOS, SEM OUTRAS QUEIXAS SATURAÇÃO 98% EM AR AMBIENTE. PA 130/80.

EF: EDEMA LOCALIZADO EM REGIÃO CERVICAL EM AMBOS OS LADOS

CD: AGUARDO LAUDOS DE TOMOGRAFIAS JÁ REALIZADAS
OBSERVAÇÃO EM SALA DE EMERGÊNCIA

|LADO
IVAN REIS MACHADO
CRM:89904-MG

Ivan Reis Machado
CRM-MG 89904
CONTROLE 5883652

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO

EVOLUÇÃO MÉDICA

Nº DO ATEND.: **676366** NOME: **NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO**
LEITO: **CLFC01** IDADE:**20a 6m** SEXO: **M** ORIGEM: **AGUANIL**
CATEGORIA: **UNIMED**

Data/Hora: 24/09/22 09:18

EVOLUÇÃO MEDICA:
PACIENTE HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL, SEM QUEIXAS, DIURESE PRESERVADA.

TC DE ABDOMEN DENTRO DA NORMALIDADE

CD:
ENCAMINHO PACIENTE PARA O LEITO DE ENFERMARIA
FAÇO RELATÓRIO PARA TRANSFERENCIA PARA REALIZAR CIRURGIA DOS JOELHOS

|LADO
BRUNA FERNANDA BELINELI
CRM:92053-MG

Dra. Bruna Fernanda Belineli
Médica
CRM-MG 92053

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO

EVOLUÇÃO MÉDICA

N° DO ATEND.: **676354** NOME: **NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO**
LEITO: IDADE:**20a 6m** SEXO: **M** ORIGEM: **AGUANIL**
CATEGORIA: **UNIMED**

Data/Hora: 24/09/22 08:53

EVOLUÇÃO MEDICA: CONTEXTO: PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CARRO-CARRO COM COLISÃO LATERAL. TRAZIDO PELO SAMU QUE RELATOU SINAIS VITAIS NORMAIS E LESÕES EM PARTE ANTERIOR DE AMBOS OS JOELHOS, SEM OUTRAS ALTERAÇÕES. PACIENTE CONSCIENTE, ORIENTADO, NEGA TCE E SE RECORDA DE TODO O EPISÓDIO, FALANDO COM CLAREZA. ÚNICA QUEIXA DOR NOS JOELHOS.

HPP: NEGA COMORBIDADES OU USO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO

AVALIAÇÃO: REAVALIO PACIENTE NO LEITO, ACOMPANHAMENTO DO IRMÃO, TRANQUILO, ORIENTADO, HEMODINAMICAMENTE ESTAVEL. RELATA OLIGÚRIA, COM DOR EM REGIÃO HIPOGÁSTRICA. CONVERSO COM IRMÃO QUE DESEJA TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA EM SÃO PAULO, REALIZO RELATORIO PARA TRANSFERENCIA.

EXAMES FÍSICOS: PA 130/70 FC 98 SAT 99% EM AA
BEG, HIDRATADO, HIPOCORADO +/4+, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO
AR: MVF SEM RA
ACV: BNFNR EM 2T
AD: ABDOME LIVRE, DOLOROSO A PALPAÇÃO PROFUNDA DE REGIÃO HIPOGÁSTRICA, RHA+
LESÃO DE APROXIMADAMENTE 6CM EM JOELHO DIREITO, COM EXPOSIÇÃO DE RETINÁCULOS
LESÃO DE APROXIMDAMENTE 3 CM EM JOELHO ESQUERDO

HD: FRATURAS DE JOELHOS BILATERAL

CD:
MANTENHO PACIENTE EM SALA VERMELHA, MOV, ANALGESIA
SOLICITO TC DE ABDOMEN TOTAL
AGUARDANDO LAUDO DA TC DE CRANIO, CERVICAL E TORAX
AGUARDANDO TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA

| LADO
BRUNA FERNANDA BELINELI
CRM: 92053-MG

Dra. Bruna Fernanda Belineli
Médica
CRM-MG 92053

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO

EVOLUÇÃO MÉDICA

Nº DO ATEND.: **676366** NOME: **NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO**
LEITO: **CLFC01** IDADE:**20a 6m** SEXO: **M** ORIGEM: **AGUANIL**
CATEGORIA: **UNIMED**

Data/Hora: 25/09/22 08:27

EVOLUÇÃO MEDICA:ORTOPEDIA - EVOLUÇÃO

CONTEXTO.: PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. TRAUMA EM AMBOS OS JOELHOS.

RX.: FRATURA PATELA ESQUERDA - TRAÇO TRANSVERSO E LESÃO DO RETINACULO EXTENSOR JOELHO DIREITO.

PROPOSTA DE TRATAMENTO CIRURGICO SEGUNDA-FEIRA (26/09/22).

EVOLUÇÃO.: 25/09/22.: EM USO DE TALA GESSADA INGUINO-MALEOLAR BILATERAL. SEM QUEIXAS ALGICAS. ACEITANDO BEM A DIETA. NEUROVASCULAR OK.

HD.: FRATURA PATELA ESQUERDA
LESÃO RETINACULO EXTENSOR JOELHO DIREITO

CD.: ACOMPANHO + PRESCREVO
PROPOSTA DE CIRURGIA COM DR CAIO SEGUNDA-FEIRA (26/09/22)
SUSPENDO DIETA A PARTIR DAS 23 HORAS DE HOJE + SUSPENDO CLEXANE

|LADO
IVAN FERREIRA REZENDE
CRM:61894-MG

Dr Ivan Ferreira Rezende
RQE Nº 42070 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
TEOT 16399 CRM MG 61894
CONTROLE 6050277

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO
EVOLUÇÃO MÉDICA

Nº DO ATEND.: **676366** NOME: **NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO**
LEITO: **CLFC01** IDADE:**20a 6m** SEXO: **M** ORIGEM: **AGUANIL**
CATEGORIA: **UNIMED**

Data/Hora: 26/09/22 08:26

EVOLUÇÃO MEDICA:PACIENTE LÇEVADO AO BLOCO CIRÚRGICO E REALIZADA OSTEOSSÍNTESE DA PATELA ESQUERDA.

| LADO
RICARDO DE SOUSA ANDRADE
CRM:027462-MG

Dr. Ricardo de Souza Andrade
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CRM MG 27462

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO
EVOLUÇÃO MÉDICA

Nº DO ATEND.: **676366** NOME: **NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO**
LEITO: **APTO01** IDADE:**20a 6m** SEXO: **M** ORIGEM: **AGUANIL**
CATEGORIA: **UNIMED**

Data/Hora: 27/09/22 09:28

EVOLUÇÃO MEDICA: PACIENTE QUEIXANDO DOR.
ALTA HOSPITALAR SUSPENSA.
CD:MANTIDA PRESCRIÇÃO.

|LADO
RICARDO DE SOUSA ANDRADE
CRM:027462-MG

Dr. Ricardo de Sousa Andrade
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CRM MG 27462

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Nº DO ATEND.: 676366 NOME: NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO LEITO: CLFC01
IDADE: 20 SEXO: M ORIGEM: AGUANIL

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

PACIENTE INTERNADO DEVIDO A UM ACIDENTE AUMOBILISTICO. RECEBO PACIENTE ADVINDO DA ALA VERDE 2. PACIENTE SUBIU DO B.C PARA ALA VERDE 2 PORÉM O MESMO TEM PLANO UNIMED, SENDO ASSIM, ENCAMINHADO AO APT 1 DA ALA AZUL (PARTICULAR). RECEBO PACIENTE EM AA, EUPNEICO. HIPOCORADO. HIDRATADO. ORIENTADO, ALERTA, COMUNICATIVO. O MESMO REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO COM DR. CAIO, ME FOI RELATADO PELA ENFERMEIRA NAARA QUE A CIRURGIA FOI DE PATELA, DEVIDO FRATURA EXPOSTA. OBS: NÃO HÁ NENHUM RELATÓRIO MÉDICO, POR ISSO SEM MAIORES INFORMAÇÕES DO CASO DO MESMO. OBSERVO PRESENÇA DE SINAL DE GUAXINIM EM REGIÃO OCULAR EXTERNA, GRAU 1. OBSERVO EDEMA DE FACE E PESCOÇO, MÃE E FAMILIARES RELATAM QUE NÃO ESTAVA "INCHADO" DESSA FORMA. PORTANDO AVP PADA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ABDOME FLÁCIDO, POUCO DISTENDIDO. JOELHOS COM ENFAIXAMENO ORTOPÉDICO. PES FRIOS COM PERFUSÃO CAPILAR PRESENTE.
FAMILIA ME PROCURA RELATANDO QUE QUER FAZER TRANSFERENCIA PARA O BENEFICIENCIA PORTUGUESA. ENTRO EM CONTATO COM DR. CAIO PARA PREENCHER PAPEIS E O MESMO RELATA QUE ESTÁ CANSADO, "EXAURIDO" DEVIDO TER REALIZADO 4 CIRURGIAS E QUE NÃO FARÁ O PREENCHIMENTO DOS PAPEIS HOJE E QUE PASSARIA O CASO PARA O PLANTONISTA DE AMANHÃ.

A EVOLUÇÃO CONTINUA...

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

PRESCRIÇÃO DE CURATIVO

24 de setembro de 2022
PROF. DE ENFERMAGEM: GEISA COSTA SALES FONTES
COREN: 528929-MG

Geisa C Sales Fontes
Enfermeira
COREN-MG 528929

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Nº DO ATEND.: 676366 NOME: NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO LEITO: CLFC01
IDADE: 20 SEXO: M ORIGEM: AGUANIL

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

APÓS APRESENTAR VOMITO COM PRESENÇA DE RAJADA DE SANGUE ENTRO EM CONTATO COM A ENFERMEIRA NAARA DO P.A, CONVERSO COM A MESMA RELATANDO SOBRE O EDEMA DE FACE E SINAL DE GUAXINIM. PERGUNTO SE FOI REALIZADO TC DE CRANIO E NÃO FOI FEITO. CONVERSO COM A MESMA SOBRE A POSSIBILIDADE DE DESCER COM O PACIENTE PARA A SALA VERMELHA E A MESMA AUTORIZA. CONVERSO COM FAMÍLIA SOBRE DESCER COM O PACIENTE PARA A SALA VERMELHA E EXPLICO QUE ELE FICARÁ MAIS SEGURA POR ESTAR MONITORADO 24H. CLIENTE É ENCAMINHADO PARA TC, PARA REALIZAR TC DE CRANIO, CERVICAL E TORAX E LOGO APÓS O MESMO FOI ENCAMINHADO PARA A SALA VERMELHA, SEM INTERCORRENCIAS.

OBS: ENTREI EM CONTATO COM DIRCEIA DA UNIMED PARA SABER SOBRE TRANSFERENCIA PARA O BENEFICIENCIA E ELA RELATOU QUE A UNIMED NÃO COBRE TRANSFERENCIA. CONVERSEI O MESMO COM A FAMILIA E MÃE DO PACIENTE RELATA QUE O PLANO DELE COBRE A TRANSFERENCIA.

PACIENTE AOS CUIDADOS DOS PROFISSIONAIS DA SALA VERMELHA NO P.A

FAMILIA AUTORIZOU DESCER COM PACIENTE PARA A SALA VERMELHA. FOI ORIENTADA SOBRE AS DEMAIS CONDUTAS.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

PRESCRIÇÃO DE CURATIVO

24 de setembro de 2022
PROF. DE ENFERMAGEM: GEISA COSTA SALES FONTES
COREN: 528929-MG

Geisa C Sales Fontes
Enfermeira
COREN-MG 528929

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Nº DO ATEND.: 676366 NOME: NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO LEITO: CLFC01
IDADE: 20 SEXO: M ORIGEM: AGUANIL

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

HD: PRÉ OPERATORIO DE FRATURA PATELA ESQUERDA
LESÃO RETINACULO EXTENSOR JOELHO DIREITO

PACIENTE RETORNA PARA O SETOR AS 16:10HS APÓS TER SEU QUADRO CLINICO ESTABILIZADO NA SALA VERMELHA DO PA ENCONTRA-SE ACOMPANHADO LUCIDO COMUNICATIVO CORADO HIDRATADO ACIANOTICO ANICTERICO AFEBRIL EUPNEICO EM AR AMBIENTE DIETA ORAL ACEITA, DIURESE PRESENTE, EVACUAÇÃO AUSENTE ATÉ O MOMENTO, SEGUE AGUARDANDO POR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO DIA 26/06 SEGUNDA FEIRA. OBS : APRESENTA EDEMA EM PESCOÇO EM AMBOS LADOS E OLHO DE GUAXINIM DR. IVAN CIENTE

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

17 - Mobilidade física prejudicada
23- Risco de infeccao

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

[16-18] Avaliar presença de edema em MMSS e MMII;

[16-18] Manter grades do leito elevadas e macas travadas;

[16-18] Proteger membro imobilizado durante banho; Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas;

[16-18] Sempre encaminhar paciente para exames em cadeira ou maca.

[23] Realizar higienização das mãos antes e apos qualquer procedimento ou manipulação de equipamentos;

[23] Realizar desinfecção de torneirinhas e extensores com álcool a 70% antes da manipulação;

[23] Comunicar presença de sinais flogísticos em inserção de cateteres e dispositivos invasivos;

PRESCRIÇÃO DE CURATIVO

24 de setembro de 2022
PROF. DE ENFERMAGEM: CLAUDIA LIMA DA SILVA
COREN:278519-MG

Cláudia Lima da Silva
ENFERMEIRA
COREN MG 278519

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

LEITO:

º DO ATEND.: 676366 NOME: NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO
LFC01
DADE: 20 SEXO: M ORIGEM: AGUANIL

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

D: PRÉ OPERATORIO DE FRATURA PATELA ESQUERDA
LESÃO RETINACULO EXTENSOR JOELHO DIREITO

NCONTRA-SE ACOMPANHADO LUCIDO, COMUNICATIVO, CORADO, HIDRATADO, ACIANOTICO, NICTERICO, AFEBRIL, EUPNEICO EM AR AMBIENTE, DIETA ORAL ACEITA, DIURESE PRESENTE, VACUAÇÃO AUSENTE ATÉ O MOMENTO, SEGUE AGUARDANDO POR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO DIA 6/06 SEGUNDA FEIRA. QUEIXANDO MUITA DOR SENDO MEDICADO COM MORFINA.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

7 - Mobilidade física prejudicada
3- Risco de infeccao

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

16-18] Avaliar presença de edema em MMSS e MMII;

16-18] Manter grades do leito elevadas e macas travadas;

16-18] Proteger membro imobilizado durante banho; Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas;

16-18] Sempre encaminhar paciente para exames em cadeira ou maca.

23] Realizar higienização das mãos antes e apos qualquer procedimento ou manipulação de equipamentos;

23] Realizar desinfecção de torneirinhas e extensores com álcool a 70% antes da manipulação;

23] Comunicar presença de sinais flogísticos em inserção de cateteres e dispositivos invasivos;

PRESCRIÇÃO DE CURATIVO

25 de setembro de 2022
PROF. DE ENFERMAGEM: ADILA DAYANA FELICO CASARINO TRINDADE
COREN:553385-MG

ÁDILA DAYANA F. C. TRINDADE
ENFERMEIRA
COREN MG 553.385

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Nº DO ATEND.: 676366 NOME: NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO LEITO: CLFC01
IDADE: 20 SEXO: M ORIGEM: AGUANIL

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

PACIENTE AOS CUIDADOS DA ORTOPEDIA COM HD DE FRATURA EXPOSTA DE PATELA ESQUERDA+LESÃO DO RETINACULO DO JOELHO DIREITO. CONSCIENTE, ORIENTADO, COMUNICATIVO, CORADO, HIDRATADO, EUPNEICO EM AR AMBIENTE, AUSCULTA CARDÍACA:RCR 2T BNF, PULMONAR:MVF+ S/RA, ABDOME LIVRE:RHA+, MIE IMOBILIZADO E COM ATADURA DEVIDO FRATURA DE PATELA, MID COM SUTURA EM REGIÃO DO JOELHO DIREITO COM BOA CICATRIZAÇÃO, REALIZADO CURATIVO, MANTÉM OCLUSIVO COM GAZE E ATADURA, DIETA ORAL BEM ACEITA, DIURESE ESPONTÂNEA PRESENTE. TOMOU BANHO NO LEITO, AVALIADO PELO DR.IVAN QUE ORIENTA ADIANTAR CLEXANE PARA ÀS 18:00H, SUSPENDER DIETA ÀS 23:00H, PROCEDIMENTO CIRURGICO SERÁ REALIZADO AMANHÃ. RETIRADO AVP NA FOSSA ANTICUBITAL ESQUERDA, PUNCIONADO AVP EM ANTEBRAÇO DISTAL ESQUERDO COM JELCO N°20, MANTÉM SALINIZADO. RELATOU CEFALÉIA, MEDICADO COM DIPIRONA E TRAMAL.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

5- Confusão aguda
17 - Mobilidade física prejudicada
19 - Deficit para o autocuidado
20 - Integridade da pele prejudicada
23- Risco de infeccao

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

[8-9] Comunicar se temperatura < 35,8o C ou > 37,8o C;
6/6 h -> 12 18 24 06
[10] Administrar analgésicos prescritos e se não prescritos comunicar a Enfermeira

[16-18] Avaliar perfusão e temperatura do membro imobilizado;

[16-18] Avaliar perfusão e temperatura do membro imobilizado;

[16-18] Proteger membro imobilizado durante banho; Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas;

[19-20] Realizar banho no leito;
1x/D h -> 10
[19-20] Auxiliar o paciente nas atividades de autocuidado (vestir, alimentar e higiene corporal)

[19-20] Realizar a hidratação da pele apos higiene corporal;

[19-20] Realizar curativo em lesão de pele de_____ com SF 0,9% morno em jato e utilizar a COBERTURA_____;

[23] Realizar higienização das mãos antes e apos qualquer procedimento ou manipulação de equipamentos;

[23] Realizar desinfecção de torneirinhas e extensores com álcool a 70% antes da manipulação;

PRESCRIÇÃO DE CURATIVO

REALIZAR CURATIVO EM SUTURA NO JOELHO DIREITO, HIGIENIZAR COM SF 0,9% SECAR COM GAZE, APÓS OCLUIR COM GAZE E ATADURA.

25 de setembro de 2022
PROF. DE ENFERMAGEM:GRACIELA PEREIRA LOPES MOREIRA
COREN:243532-MG

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Nº DO ATEND.: 676366 NOME: NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO LEITO: CLFC01
IDADE: 20 SEXO: M ORIGEM: AGUANIL

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

PACIENTE AOS CUIDADOS DA ORTOPEDIA COM HD DE FRATURA EXPOSTA DE PATELA ESQUERDA+LESÃO DO RETINACULO DO JOELHO DIREITO. CONSCIENTE, ORIENTADO, COMUNICATIVO, CORADO, HIDRATADO, EUPNEICO EM AR AMBIENTE, AUSCULTA CARDÍACA:RCR 2T BNF, PULMONAR:MVF+ S/RA, ABDOME LIVRE:RHA+, MIE IMOBILIZADO E COM ATADURA DEVIDO FRATURA DE PATELA, MID COM SUTURA EM REGIÃO DO JOELHO DIREITO COM BOA CICATRIZAÇÃO, REALIZADO CURATIVO, MANTÉM OCLUSIVO COM GAZE E ATADURA, DIETA ORAL BEM ACEITA, DIURESE ESPONTÂNEA PRESENTE. SUSPENSO CLEXANE, ORIENTO JEJUM APÓS ÀS 23:00H, PROCEDIMENTO CIRURGICO SERÁ HOJE. AVP SALINIZADO EM ANTEBRAÇO DISTAL ESQUERDO COM JELCO N°20. RELATOU DOR, MEDICADO COM DIPIRONA, TRAMAL E TCP DE DIAZEPAN 10MG VO.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

5- Confusão aguda
17 - Mobilidade física prejudicada
19 - Deficit para o autocuidado
20 - Integridade da pele prejudicada
23- Risco de infeccao

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

[8-9] Comunicar se temperatura < 35,8o C ou > 37,8o C;
6/6 h -> 12 18 24 06
[10] Administrar analgésicos prescritos e se não prescritos comunicar a Enfermeira

[16-18] Avaliar perfusão e temperatura do membro imobilizado;

[16-18] Avaliar perfusão e temperatura do membro imobilizado;

[16-18] Proteger membro imobilizado durante banho; Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas;

1x/D h -> 10
[19-20] Auxiliar o paciente nas atividades de autocuidado (vestir, alimentar e higiene corporal)

[19-20] Realizar a hidratação da pele apos higiene corporal;

[23] Realizar higienização das mãos antes e apos qualquer procedimento ou manipulação de equipamentos;

[23] Realizar desinfecção de torneirinhas e extensores com álcool a 70% antes da manipulação;

PRESCRIÇÃO DE CURATIVO

25 de setembro de 2022
PROF. DE ENFERMAGEM:GRACIELA PEREIRA LOPES MOREIRA
COREN:243532-MG

Santa Casa
CAMPO BELO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Nº DO ATEND.: 676366 NOME: NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO LEITO: APTO01
IDADE: 20 SEXO: M ORIGEM: AGUANIL

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

CLIENTE ENCAMINHADO AO BLOCO. RETORNANDO 11:30.
LIBERADO DIETA ÀS 13. BOS ACEITAÇÃO. DIURESE E EVACUAÇÃO AUSENTE. QUEIXA DOR EM SITIOS CIRURGICO. AO EXAME CONSCIENTE ORIENTADO COMUNICATIVO. HIPOCORADO. AVP EM MSD. EUPNEICO AA, EUCARDICO BCNF2T. ABDOME INDOLOR SEM MASSAS. MMII IMOBILIZADOS POS CIRURGICO.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

5- Confusão aguda
17 - Mobilidade física prejudicada
19 - Deficit para o autocuidado
20 - Integridade da pele prejudicada
23- Risco de infeccao

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM

[8-9] Comunicar se temperatura < 35,8o C ou > 37,8o C;
6/6 h -> 12 18 24 06
[10] Administrar analgésicos prescritos e se não prescritos comunicar a Enfermeira

[16-18] Avaliar perfusão e temperatura do membro imobilizado;

[16-18] Avaliar perfusão e temperatura do membro imobilizado;

[16-18] Proteger membro imobilizado durante banho; Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas;

1x/D h -> 10
[19-20] Auxiliar o paciente nas atividades de autocuidado (vestir, alimentar e higiene corporal)

[19-20] Realizar a hidratação da pele apos higiene corporal;

[23] Realizar higienização das mãos antes e apos qualquer procedimento ou manipulação de equipamentos;

[23] Realizar desinfecção de torneirinhas e extensores com álcool a 70% antes da manipulação;

PRESCRIÇÃO DE CURATIVO

26 de setembro de 2022
PROF. DE ENFERMAGEM: JHONATAS OLHER COUTINHO
COREN:671075-MG

